Motilidad, reflejos, taxia y praxias

SEMIOLOGIA · Clase 37 · fuerza, reflejos osteotendinosos, Babinski, coordinación y funciones superiores

1 · DEBILIDAD: GRADO, EXTENSIÓN Y NIVEL

Fuerza
se explora por grupos musculares, contra resistencia y gravedad, comparando lados; escala 0 a 5

si es incompleta: → **Paresia** (F1)
fuerza disminuida (pérdida incompleta)

si es completa: → **Plejía** (F1)
pérdida total de la fuerza

si es leve, se destapa con → Posición sostenida

se nombra por su

se nombra por su

Extensión (F1)
mono- (un miembro), hemi- (medio cuerpo; braquiocrural si toma la cara), para- (miembros inferiores), cuadri- (los cuatro)

se completa con el

Tono y trofismo (F1)
hipotonía, espasticidad, rigidez; hipotrofia y atrofia

junto con los reflejos, ubica el

Ubicar el nivel
superior: hiperreflexia + Babinski, sin atrofia; inferior: atrofia tras la 3.ª semana e hiporreflexia; unión: fatigabilidad; músculo: proximal con reflejos conservados

así se llega al

Nivel de lesión orientado: el patrón dirige los estudios

2 · PARESIA LEVE: POSICIÓN SOSTENIDA

Posición sostenida
sin resistencia la paresia leve pasa inadvertida; contra la gravedad el miembro parético se cansa antes

se logra con → **Mingazzini** (F2)
brazos extendidos al frente con ojos cerrados, o piernas en decúbito dorsal con caderas y rodillas a 90°
si es positivo: → **Positivo** (F2)
el brazo desciende y prona; la pierna cae
delata una → **Paresia piramidal leve** detectada

y en decúbito prono con → **Barré** (F2)
decúbito prono con rodillas flexionadas a 90°
si es positivo: → **El ombligo sube** (F3)
la mitad inferior del recto abdominal está paralizada
localiza la lesión en → Lesión medular o radicular alrededor de T10 (F3)

otra forma de buscarla: → **Beevor** (F3)
decúbito dorsal, intenta flexionar cabeza o tronco contra resistencia
si es positivo: → (ver "El ombligo sube")

3 · REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS Y SU ARCO

se afina con el → **Percusión del tendón**
miembro relajado en posición intermedia, golpe suave y rápido, comparando con el otro lado; si no sale, Jendrassik

su respuesta se explica por el → **Arco monosináptico** (F4)
el martillo estira el huso; la aferente entra por el asta posterior y hace sinapsis directa con la motoneurona anterior
si la vía piramidal se lesiona, → Traducen **lesión de la vía piramidal**: el arco queda liberado

en el brazo: → **Bicipital y tricipital** (F4)
bicipital: antebrazo en semiflexión-semisupinación, pulgar del explorador sobre el tendón; tricipital: codo a 90°, tendón sobre el olécranon
responden con → Bicipital flexiona el antebrazo (C5-C6); tricipital extiende (C6-C7) (F4)

en pierna y pie: → **Rotuliano y aquiliano**
rotuliano: extiende la pierna, L2-L4; aquiliano: extiende el pie, L5-S1-S2
si se exalta, puede dar → **Hiperreflexia y clonus**
contracción-relajación rápida tras una extensión brusca pasiva
traduce

cada lado se gradúa con la → **Graduación**
escala 2018 de 0 a 5 (3 normal, 5 con clonus); apunte 2020 de 0 a 4 cruces: declarar cuál se usa
en el grado 5 aparece el

4 · REFLEJOS DE LA PIEL Y DE LIBERACIÓN

en la piel, se estimula la planta: → **Respuesta plantar** (F5)
se estimula la planta; lo normal es que los dedos se flexionen

si la vía piramidal falla: → **Babinski** (F5)
dorsiflexión del dedo gordo, a veces con los demás dedos abiertos en abanico
traduce lesión de la → Lesión de la **vía piramidal** (motoneurona superior) (F5)

en el muslo se busca el → **Cremasteriano** (F6)
reflejo cutáneo: se estimula la cara interna del muslo
si es normal: → **Asciende el testículo** del mismo lado; centro L1-L2 (F6)
si falta, orienta a lesión → Su abolición orienta a lesión piramidal o de ese segmento (F6)

en la palma se busca el → **Palmomentoniano** (F7)
rozar la eminencia tenar contrae la borla del mentón del mismo lado
es un → **Reflejo primitivo** (F7)
la corteza frontal lo inhibe; si se daña, se libera
si está marcado, sugiere → Marcado o bilateral: lesión frontal difusa o demencia (F7)

5 · COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO

Cerebelo
frena el movimiento en el punto exacto, con la fuerza intacta

si hay ataxia sin debilidad, mira el → **Ataxia** (F8)
falta de coordinación de los movimientos sin pérdida de fuerza

si toma la marcha o el tronco, → Si toma la marcha o el tronco: línea media, vermis (F8)

se explora con el → **Índice-nariz** (F10)
mide la metría; también las líneas paralelas: unir dos líneas verticales con trazos horizontales
si falla, revela → **Dismetría** (F10)
se pasa (hipermetría) o no llega (hipometría)
localiza en el → **Dismetría cerebelosa** (F10)

se acompaña de otros → **Otros signos cerebelosos**
asinergia (movimiento descompuesto), adiadococinesia (no alterna rápido), temblor de acción

con fuerza normal, explora las → el equilibrio se explora con el

Romberg (F9)
de pie, pies juntos, sin apoyo; primero ojos abiertos y luego cerrados
si se pierde la vista, → **Romberg positivo** (F9)
oscilación marcada o caída al cerrar los ojos; normal: oscilaciones mínimas
revela un déficit → Déficit de **propiocepción** (cordones posteriores) o **vestibular**; no es cerebelo puro

6 · PRAXIAS Y FUNCIONES SUPERIORES

Praxia (F11)
gesto motor aprendido, dirigido a un propósito: peinarse, vestirse, usar un objeto
si se pierde con fuerza normal: → **Apraxia** (F11)
pérdida de esa destreza sin alterar fuerza, sensibilidad, coordinación ni comprensión
solo vale sin → **Con paresia no se explora**
una apraxia no es una paresia
si no hay paresia, se pasa a las → **Funciones superiores** (F12)
con el paciente despierto y alerta: orientación, atención, memoria, cálculo, lenguaje, praxias, gnosias y juicio
se resumen en el → **Mini-mental (MMSE)** (F12)
resume esas funciones en una prueba de cabecera
debe ajustarse a la → **Baja escolaridad**
rinde peor: un puntaje bajo no siempre es deterioro
por eso conviene reconocer la → Red cortical alterada con vías motora y sensitiva íntegras
orienta a una

técnica · concepto · signo · diagnóstico · desenlace · mecanismo · síndrome · ejemplo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 11b, 11c, 11f y 11i · Dr. Sotomayor — teoría del docente (= literatura)